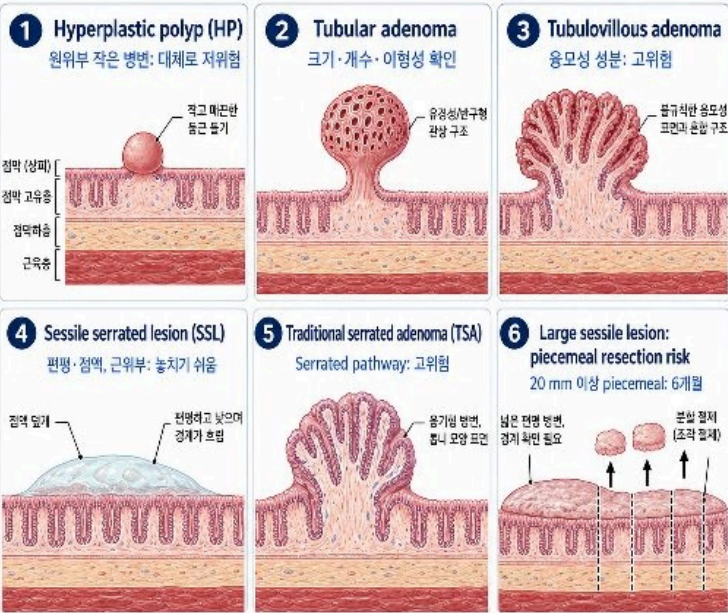


대장용종 위험도 분류와 Surveillance Colonoscopy

의료진 공부용 · 국내 2022 폴립절제 후 추적대장내시경 지침 중심

암기: 고위험 소견이 없으면 5-10년, 선종·SSL 3-4개면 3-5년, 10 mm 이상·5개 이상·villous/HGD·TSA·dysplastic SSL이면 3년임. 선종 10개 초과는 1년, 20 mm 이상 piecemeal 절제는 6개월 scar check를 시행함.



High-risk findings → shorter surveillance

1 Number

Adenoma or SSL ≥3: risk increases

Adenoma >10: 1-year follow-up + consider genetic evaluation

2 Size

Adenoma or serrated polyp ≥10 mm: high risk

Piecemeal resection of lesion ≥20 mm: 6-month scar check

3 Histology (Bx/pathology)

- Tubulovillous or villous adenoma
- High-grade dysplasia (HGD)
- SSL with dysplasia or TSA

4 Morphology / resection

- Flat, mucus-capped proximal lesion → consider SSL
- Incomplete or piecemeal resection → early recheck

High-risk lesion: 3-year surveillance in most cases
(Korean 2022 guidance)

용종 형태·조직병리·고위험 기준 모식도

용종 위험도 판정

조직형별 핵심

유형	위험도	핵심 포인트
Hyperplastic polyp	낮음	원위부 작은 HP는 저위험. 근위부·큰·다발성 HP는 SSL 감별.
Tubular adenoma	낮음~중간	개수, 크기, 이형성에 따라 재분류.
SSL / TSA	중간~높음	SSL은 편평·점액성 근위부 병변. TSA/dysplastic SSL은 고위험.
Villous / HGD	높음	용모성 성분 또는 HGD는 진행성 선종 인자.

고위험 기준

항목	위험 상승 기준	통상 F/U
개수	선종/SSL 3개 이상; 선종 10개 초과는 초고위험	3-5년; >10개는 1년
크기	선종 또는 serrated polyp 10 mm 이상	3년
Bx/병리	Villous/tubulovillous, HGD, TSA, SSL with dysplasia	3년
절제법	20 mm 이상 piecemeal EMR/ESD, 불완전절제 의심	6개월

원칙: 여러 기준이 겹치면 가장 짧은 간격을 적용함.

악성용종/pT1 CRC는 일반 용종 F/U 대신 병리 위험인자 평가 및 다학제 경로로 전환함.

저위험 스케줄

암기: 정상, 작은 원위부 HP, 또는 10 mm 미만 LGD 관상선종 1-2개는 5-10년임. Dysplasia 없는 10 mm 미만 SSL 1-2개도 5-10년으로 보되, 근위부 편평·점액성 병변은 SSL 및 완전절제를 재확인함.

기준 내시경 소견	다음 F/U	메모
정상 대장내시경	5-10년	장정결 양호, 맹장 도달, 충분한 관찰 전제.
직장·S상결장 HP만, 모두 10 mm 미만	5-10년	근위부·큰·다발성 HP는 SSL 감별 필요.
관상선종 1-2개, 모두 10 mm 미만, LGD	5-10년	완전절제 확인.
SSL 1-2개, 모두 10 mm 미만, dysplasia 없음	5-10년	병리진단 신뢰도와 완전절제 확인.

고위험 스케줄

암기: 3-4개는 3-5년, 5개 이상 또는 10 mm 이상은 3년, 10개 초과는 1년으로 외움. Villous component, HGD, TSA, dysplastic SSL도 3년이며, 20 mm 이상 piecemeal 절제는 6개월 scar check가 원칙임.

위험층	소견	다음 F/U	실무 포인트
중간	선종 또는 SSL 3-4개, 모두 10 mm 미만, non-advanced	3-5년	장정결·절제확실성 고려.
고위험	선종 5-10개, SSL 5개 이상, adenoma/serrated polyp 10 mm 이상	3년	진행성 또는 다발성 병변.
고위험	Tubulovillous/villous adenoma, HGD adenoma, TSA, SSL with dysplasia	3년	완전절제 전제.
초고위험	선종 10개 초과	1년	유전평가 고려.
국소재발	20 mm 이상 adenoma/SSL piecemeal 절제 또는 불완전절제 의심	6개월	Scar check 후 단계적 추적.

근거: Korean Guidelines for Postpolypectomy Colonoscopic Surveillance: 2022 Revised Edition (Clin Endosc 2022); 대한의사협회지 2023 국내 개정 지침 해설. 교육용 요약임.